

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico e Estratégia
Empresarial (PPGDEE)

Fernando André de Souza

CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DOS
CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE: UMA ANÁLISE
PARA MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAIS.

Montes Claros – MG

Novembro / 2025

Fernando André de Souza

**CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DOS
CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE: UMA ANÁLISE
PARA MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAIS.**

**Projeto de Pesquisa requerido na disciplina
de Seminário de Dissertação, para
composição da avaliação.**

Orientador: Luiz Paulo Fontes de Rezende

Coorientadora: Camila Lins Rodrigues.

Montes Claros – MG

Novembro / 2025

Montes Claros – MG

Novembro / 2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	04
2. PROBLEMATIZAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO	09
3. JUSTIFICATIVA	11
4. REFERENCIAL TEÓRICO	14
4.1. OS CONSELHOS PROPRIAMENTE DITOS	20
5. INSTITUIÇÕES FORTES E CONTROLE SOCIAL: IMPLICAÇÕES PARA O DESEMPENHO ECONÔMICO	23
6. ESTUDOS AFINS	26
7. A GOVERNANÇA, O PLANEJAMENTO E OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NO SUS: O PAPEL FUNDAMENTAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	29
7.1. HIERARQUIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO NO SUS: FUNDAMENTOS E FUNCIONAMENTO NAS ESFERAS DE PODER	32
7.2. FUNCIONAMENTO NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	33
7.3. PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO – PDR	34
8. METODOLOGIA	37
8.1. PESQUISA DOCUMENTAL	37
8.2. ENTREVISTAS SEMI ESTRUTURADAS	37
8.3. MODELO QUADRIPOlar DE PESQUISA	38
8.4. ANÁLISE DE CONTEÚDO	39
8.5. VALIDAÇÃO E GENERALIZAÇÃO	39
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	40

1. INTRODUÇÃO

O Estado democrático de direito no Brasil fundamenta-se no princípio da soberania popular, onde o poder é exercido pelos cidadãos por meio de eleições periódicas e universais. Neste sistema, os representantes eleitos têm a responsabilidade de garantir o bem-estar social, promovendo políticas públicas que atendam às necessidades básicas da população em áreas fundamentais, como saúde, educação e segurança. A Constituição de 1988, marco da redemocratização, estabelece um conjunto de direitos e garantias fundamentais que buscam assegurar a participação cidadã no processo de decisão política e o controle das ações estatais, por meio de mecanismos de controle social.

Aos gestores eleitos são imbuídas as responsabilidades para a resolução das questões políticas e administrativas espelhadas nos anseios do povo, e para tanto, estratégias de políticas públicas são sugeridas e executadas. No processo de instauração destas políticas devem ser observadas as necessidades reais dos destinatários das mesmas, e sua execução deve estar alinhada com os princípios legais vigentes, a fim de coibir possíveis distorções na aplicação das mesmas.

Entretanto, a implementação e o acompanhamento dessas políticas nem sempre são homogêneos, especialmente em regiões periféricas, como a Região Norte de Minas Gerais. As disparidades regionais mineiras refletem a concentração histórica do desenvolvimento no centro-sul do estado e evidenciam o menor dinamismo econômico das mesorregiões Norte e Jequitinhonha, refletindo um padrão histórico de concentração produtiva no estado. (CIRINO; GONZÁLEZ, 2021). Nesta região, marcada por desafios socioeconômicos e históricos, as dificuldades de acesso a serviços públicos e da garantia da efetividade das políticas públicas se ampliam e culminam em um movimento pendular em busca de serviços de saúde pela população (PALHARES; HERMANO E SILVA, 2023).

De acordo com o estudo de MELO, SANTOS E SANTOS (2021), que versam sobre a construção do Índice Social e de Saúde (ISS) desenvolvido para a região do Norte de Minas Gerais, referente ao ano de 2010 a região norte apresenta acentuadas desigualdades nos indicadores sociais e de saúde e observa-se que o índice médio regional é considerado baixo, refletindo profundas desigualdades socioeconômicas e territoriais. A pesquisa destaca que parte dessas disparidades decorre da distribuição desigual de recursos públicos entre os municípios, uma vez que localidades de maior porte tendem a receber investimentos mais expressivos em

comparação às de menor capacidade administrativa. Os resultados apontam, contudo, para melhorias graduais nos indicadores sociais e de saúde nas últimas décadas, especialmente após a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa evolução demonstra que o sistema público de saúde brasileiro teve impacto positivo sobre as condições de vida da população, ainda que de forma heterogênea, entre as microrregiões. Mesmo com esses avanços, o estudo ressalta que o direito universal à saúde continua sendo violado em diversos contextos, afetando principalmente a população mais pobre, que depende integralmente dos serviços públicos. O trabalho também evidencia que o SUS representou um marco na estruturação da política de saúde nacional, ampliando o acesso e promovendo melhorias significativas na atenção básica, especialmente entre os grupos vulneráveis. Todavia, a persistência das desigualdades regionais impõe a necessidade de políticas mais eficientes e equitativas, capazes de garantir condições de saúde mais justas entre os diferentes municípios.

É possível inferir, diante do panorama da região em que se assenta o estudo, que a gestão pública local enfrenta obstáculos relacionados à desigualdade regional, à escassez de recursos e à vulnerabilidade social de uma grande parcela da população.

Nesse cenário, torna-se fundamental compreender se os entraves enfrentados na Região Norte de Minas Gerais não decorrem apenas da limitação de recursos ou da desigualdade socioeconômica, mas também da fragilidade dos mecanismos de acompanhamento e fiscalização das ações governamentais. A ausência de uma cultura consolidada de controle social e institucional contribui para que políticas públicas, muitas vezes, não alcancem os resultados esperados, evidenciando a necessidade de fortalecer instrumentos que assegurem maior transparência, responsabilidade e participação cidadã no processo de gestão.

Para tanto o conceito de controle é um dos fundamentos para a consolidação do Estado Democrático de Direito, pois assegura que os gestores públicos atuem de forma ética, eficiente e conforme o interesse coletivo. O controle pode ser classificado como interno, quando exercido por órgãos da própria administração pública sobre suas atividades, como as controladorias e corregedorias; ou externo, quando realizado por instituições independentes, como os Tribunais de Contas e o Poder Legislativo, com apoio técnico especializado. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil (1988), o controle também pode ser exercido diretamente pela população, por meio dos chamados remédios constitucionais, como a ação popular, o mandado de segurança e o habeas corpus, e ainda por meio da participação em

conselhos de políticas públicas e órgãos colegiados, os quais têm a função de acompanhar, deliberar e fiscalizar a execução das ações governamentais. Esses mecanismos garantem que as decisões públicas reflitam as necessidades reais da sociedade, fortalecendo a legitimidade e a transparência na gestão. DI PIETRO (2015) entende o controle da Administração Pública como um instrumento essencial da democracia. Para ela, o controle não se limita ao âmbito interno, pelos próprios órgãos do Estado, ou externo, pelos Tribunais de Contas e Legislativo, mas deve incluir também o controle social, exercido diretamente pelo cidadão e pela sociedade civil. Assim, a boa administração pública depende de um equilíbrio entre autonomia administrativa e participação social, legitimando a atuação do Estado perante a coletividade.

A Constituição Brasileira de 1988 também estabelece, em diversos de seus artigos, a necessidade de participação da sociedade nas decisões sobre saúde, educação, assistência social e outros temas, com a intenção de promover uma gestão pública mais transparente e responsável.

A Carta Magna estabelece, em seu artigo 1º, parágrafo único, que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” (BRASIL, 1988, art. 1º, §1º). Já no campo da saúde, o artigo 198, inciso III, prevê a participação da comunidade como uma diretriz da organização do Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa forma, a Constituição de 1988 consagra o controle social como um direito e um dever do cidadão, sendo base fundamental para a construção de uma gestão pública participativa, transparente e voltada ao interesse coletivo.

Chega-se então a um ponto importante dentro dos requisitos para o desenvolvimento econômico: a participação popular, que também pode ser entendida como um requisito ou componente necessário para o desenvolvimento. Assim, esse componente democrático, na medida em que estabelece estruturas políticas que favorecem a participação, a transparência e a responsabilidade na gestão pública, envolve diferentes setores da sociedade e contribui para a formulação de políticas mais equilibradas e voltadas ao bem-estar coletivo. Esse processo de inclusão permite identificar demandas sociais diversas, como educação, saúde e infraestrutura, que são essenciais para aumentar a produtividade e fortalecer a competitividade econômica.

Além disso, a democracia cria um ambiente de previsibilidade e segurança jurídica, reduzindo riscos e estimulando investimentos privados e estrangeiros. Quando os direitos individuais e a propriedade são protegidos, empresários e investidores sentem-se mais confiantes para planejar iniciativas de longo prazo, gerando empregos, inovação tecnológica e diversificação

econômica. A participação cidadã, característica central da democracia, também favorece a fiscalização e o controle social sobre o uso dos recursos públicos, diminuindo a corrupção e promovendo uma gestão mais eficiente e responsável.

Outro aspecto relevante é a capacidade da democracia de reduzir desigualdades por meio de políticas redistributivas e programas sociais elaborados e implementados de maneira transparente. A democracia, ao favorecer o debate público e o controle social das decisões governamentais, cria condições para que os recursos sejam direcionados de forma mais equitativa, atendendo às demandas de grupos historicamente marginalizados. Como destaca SEN (2000), o desenvolvimento não se restringe ao crescimento econômico, mas consiste na ampliação efetiva das liberdades individuais e coletivas, permitindo que as pessoas possam viver a vida que valorizam. Nessa perspectiva, políticas que asseguram educação, saúde e proteção social ampliam as capacidades humanas e fortalecem a cidadania, constituindo-se como instrumentos de justiça social.

De modo convergente, STIGLITZ (2013) observa que o fortalecimento das instituições democráticas e da transparência pública é essencial para mitigar as distorções provocadas pela concentração de renda e de poder político, promovendo um crescimento econômico mais sustentável e inclusivo. A inclusão econômica e social, ao ampliar o acesso a oportunidades e fortalecer o mercado consumidor, cria uma base mais sólida para o desenvolvimento de longo prazo. BOBBIO (1986) complementa que a democracia contemporânea deve ser compreendida como um processo em constante aperfeiçoamento, cujo êxito depende da efetivação dos direitos civis, políticos e sociais. Assim, ao articular liberdade política, justiça social e estabilidade institucional, o componente democrático não apenas consolida direitos e liberdades, mas também estabelece os fundamentos necessários para um desenvolvimento duradouro, capaz de gerar prosperidade compartilhada e resiliência frente às crises.

No contexto latino-americano, FURTADO (2009) já advertia que o subdesenvolvimento não é uma etapa natural do progresso, mas o resultado de estruturas históricas que perpetuam desigualdades internas e externas. Para ele, o desenvolvimento só é efetivo quando associado à democratização do poder e à valorização das potencialidades locais, rompendo com a lógica da dependência e da concentração de renda. Nessa mesma direção, BRESSER-PEREIRA (2018) argumenta que o desenvolvimento nacional depende da construção de um Estado democrático e capaz de coordenar políticas que conciliem estabilidade macroeconômica com inclusão social, superando o dualismo entre eficiência e equidade. Já SANTOS (2021) enfatiza que a

democracia só se realiza plenamente quando incorpora a dimensão participativa, reconhecendo a pluralidade de saberes e experiências que emergem dos territórios e das comunidades.

Essas reflexões ajudam a compreender o caso do Norte de Minas Gerais, região que historicamente apresenta baixos indicadores socioeconômicos e desigualdades persistentes nos serviços públicos, especialmente na área da saúde (MELO; SANTOS; SANTOS, 2021). A fragilidade institucional e a limitada capacidade de planejamento dos entes municipais evidenciam um déficit democrático estrutural, em que a participação popular e o controle social ainda se desenvolvem de forma desigual. Assim, a efetivação da democracia participativa — expressa nos Conselhos Municipais de Saúde e nos espaços de deliberação coletiva — torna-se fundamental para a promoção de políticas redistributivas e de fortalecimento da gestão pública. Nesse sentido, a consolidação de práticas democráticas na região não é apenas uma questão política, mas um requisito para o desenvolvimento econômico e social sustentável, capaz de articular cidadania, equidade e justiça territorial.

2. PROBLEMATIZAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

Apesar das garantias constitucionais, o controle social e a participação popular ainda enfrentam diversos desafios no Brasil, especialmente em áreas mais distantes dos grandes centros urbanos, como é o caso da delimitação deste estudo que foca Municípios da Região Norte de Minas Gerais. Nessa região, a implementação de políticas públicas sofre com a carência de infraestrutura, com a falta de capacitação dos gestores públicos locais e com a limitação no acesso a canais formais de participação, como conselhos e audiências públicas. As populações rurais e periféricas enfrentam, ainda, barreiras culturais e educacionais que dificultam sua plena participação nos processos decisórios.

No Brasil, apesar dos percalços, o controle social das políticas públicas tem sido amplamente promovido nas últimas décadas, mas sua eficácia varia consideravelmente de acordo com as regiões. Segundo estudo de ROCHA E LIMA (2019), a região Norte enfrenta desafios como a concentração de renda, a escassez de serviços públicos básicos, e uma infraestrutura precária que dificulta o acesso da população a direitos fundamentais como saúde e educação. A atuação do controle social é, muitas vezes, limitada pela baixa escolaridade e pela falta de conhecimento sobre os direitos da população, o que prejudica a mobilização social e a cobrança por melhorias.

A participação em conselhos municipais, que deveria ser um mecanismo eficaz de controle e formulação de políticas, é muitas vezes ineficaz nessa região devido ao baixo nível de engajamento da população e à falta de capacitação dos representantes locais. Além disso, a grande distância entre as comunidades rurais e os centros urbanos acentua as dificuldades no acesso a informações e na participação nas decisões políticas.

Portanto, embora a Constituição de 1988 tenha estabelecido mecanismos robustos para a participação social e o controle das políticas públicas no Brasil, os desafios enfrentados pelas populações de regiões como o Norte de Minas Gerais evidenciam a necessidade de estratégias específicas para garantir que esses direitos se traduzam em mudanças concretas na vida da população. A efetividade do controle social e a verdadeira participação popular podem depender não apenas da existência de normas e estruturas formais, mas também do fortalecimento da educação cívica, do acesso à informação e do empoderamento das comunidades locais.

Desta forma, formula-se a questão que se busca esclarecer: **Como tem se dado a participação dos conselhos na execução das políticas públicas no setor de Saúde da Região Norte de**

Minas Gerais? Observa-se congruência das suas atividades com o propósito a que se destina?

Para tanto, tem-se por objetivo geral deste trabalho a análise da atuação dos conselhos de políticas públicas nas áreas de saúde da Região Norte de Minas Gerais. Como objetivos específicos, busca-se: 1) identificar a composição dos conselhos (perfil de sexo, idade, escolaridade, condições socioeconômicas); 2) descrever a validação legal que os estrutura; e 3) verificar o nível de engajamento popular presente nos conselhos e sua influência sobre a execução das políticas de saúde.

Para a realização desta pesquisa, entende-se ser necessário, em primeiro lugar, definir o universo da pesquisa. O Norte de Minas Gerais possui 89 municípios e 85 conselhos de saúde presentes no Cadastro dos Conselhos de Saúde do Estado de Minas Gerais. Dada a impossibilidade de investigação de todos esses conselhos a partir desta pesquisa, serão definidos quatro municípios com conselhos de saúde atuantes: 1) Montes Claros, por ser a maior cidade da região com a função de polo macrorregional; 2) um município com IDH baixo; 3) um município com IDH médio e 4) um município com IDH alto. Esse recorte busca dar representatividade socioeconômica aos municípios e às microrregiões de saúde da região.

A partir desse recorte, será realizada análise qualitativa da atuação e dos resultados de ação destes quatro Conselhos frente à realidade em que estão inseridos, o que pode ser viabilizado a partir da realização de pesquisa de campo e coleta de dados primários junto aos atores envolvidos no processo (participantes dos conselhos e autoridades públicas) e, também, pela coleta e leitura de documentos públicos.

Espera-se, com os dados levantados, visualizar o nível de engajamento e participação da população nas decisões colegiadas nestes municípios. A identificação, a partir dos produtos jurídicos e/ou administrativos, dos trabalhos executados pelos conselhos e a interpretação da qualidade destes trabalhos e das decisões contidas nos mesmos auxiliarão no elucidamento da questão do alinhamento entre papéis institucionais e a lide prática destes órgãos.

3. JUSTIFICATIVA

A Região Norte de Minas Gerais, palco deste estudo, com seus 128.454,108 quilômetros quadrados, é composta por 89 municípios, é uma área historicamente marcada pelo subdesenvolvimento e desigualdades sociais. A falta de infraestrutura básica, aliada a uma escassez de recursos financeiros e humanos, torna difícil a implementação de políticas públicas eficazes. Além disso, a fragilidade das instituições públicas na região reflete-se diretamente na formação e na atuação dos conselhos de políticas públicas. Esses conselhos, que deveriam atuar como órgãos de controle social e garantir que as políticas públicas atendam às reais necessidades da população, muitas vezes não possuem impacto concreto e se limitam a uma mera formalidade legal, sem a efetiva participação da sociedade ou a capacidade de corrigir falhas nas políticas implementadas.

No contexto da saúde pública, o presente estudo tem como recorte os Conselhos Municipais de Saúde localizados na região Norte de Minas Gerais. Esses espaços colegiados, instituídos pela Lei nº 8.142/1990, que se configuram como instâncias permanentes e deliberativas do Sistema Único de Saúde (SUS), responsáveis por formular estratégias e fiscalizar a execução das políticas públicas em nível local. Sua importância transcende o caráter consultivo: os conselhos expressam a concretização do princípio democrático da participação popular, previsto na Constituição Federal de 1988, e materializam o controle social como elemento estruturante da gestão descentralizada. Assim, analisar a atuação e a efetividade desses conselhos significa compreender em que medida a democracia participativa contribui para o fortalecimento institucional do SUS e para a redução das desigualdades regionais em saúde. Nesse sentido, o estudo não apenas examina os mecanismos de representação e deliberação existentes nesses colegiados, mas também busca avaliar como eles influenciam a formulação de políticas e a distribuição equitativa de recursos no território norte-mineiro.

A justificativa deste estudo encontra sustentação na relevância social e científica de analisar o controle social na saúde pública em um contexto de profundas desigualdades regionais, acentuadas pela pandemia da Covid-19. A crise sanitária evidenciou, de forma incontestável, o papel essencial do Sistema Único de Saúde (SUS) como principal instrumento de proteção da população brasileira diante de emergências de saúde pública e de vulnerabilidades socioeconômicas.

Ao longo da pandemia, o SUS revelou-se uma política pública estratégica para a sobrevivência coletiva, responsável por coordenar ações de vigilância, vacinação, atendimento hospitalar e campanhas de prevenção em todo o território nacional. Contudo, também se tornaram mais visíveis as limitações estruturais e desigualdades regionais que comprometem a equidade e a efetividade do sistema. No Norte de Minas Gerais, por exemplo, observou-se uma combinação crítica de escassez de recursos humanos, infraestrutura hospitalar insuficiente e dependência das transferências federais, o que expôs as fragilidades históricas da região.

Essas desigualdades não se restringem ao campo sanitário, mas refletem uma estrutura social profundamente assimétrica, marcada pela concentração de renda, baixa capacidade de investimento público e frágil institucionalidade democrática. Nesse cenário, os Conselhos Municipais de Saúde assumem papel fundamental na articulação entre Estado e sociedade civil, atuando como instrumentos de controle social, deliberação e fiscalização das políticas de saúde.

Dentro deste contexto, surge a necessidade de aprofundar os estudos sobre os mecanismos de controle social e de participação popular já estabelecidos, como os conselhos de políticas públicas, que, em teoria, deveriam ser instrumentos eficazes para corrigir desvios nas políticas públicas e garantir a transparência na gestão. Embora o Brasil tenha instituído esses mecanismos, a efetividade deles é questionada, especialmente em regiões como o Norte de Minas Gerais, onde as dificuldades estruturais da administração pública impactam diretamente a funcionalidade desses conselhos.

A relevância desta pesquisa, portanto, reside em compreender de que forma o controle social, exercido pelos conselhos, contribui para a efetividade das políticas públicas de saúde em regiões periféricas, desiguais e historicamente marginalizadas. Além de preencher lacunas teóricas sobre a interface entre participação popular, desenvolvimento e saúde, o estudo busca oferecer uma análise aplicada sobre os limites e potencialidades da democracia participativa no contexto da descentralização do SUS.

Assim, os resultados obtidos a partir da presente pesquisa contribuirão para a identificação e descrição de problemas estruturais na operacionalização dos conselhos, servindo de material base para o desenvolvimento de estratégias inovadoras acerca da solução de questões ligadas ao tema pesquisado, florescendo e frutificando na forma de manuais ou guias práticos, que orientem a formulação, instalação e funcionamento desses conselhos, promovendo a integração dos entes

públicos da região e fortalecendo a participação popular no processo de formulação e monitoramento das políticas públicas.

4. REFERENCIAL TEÓRICO

Compreender as bases da participação popular na organização dos Estados é essencial para entender a evolução do poder político. Desde as primeiras formas de convivência humana, baseadas na cooperação e na divisão de tarefas (HARARI, 2015), até os sistemas democráticos atuais, a participação social sempre foi um elemento central da vida política. Na Grécia Antiga, Aristóteles já afirmava que “o homem é por natureza um animal político”, destacando a importância da deliberação pública. Com a Revolução Francesa, consolidou-se a ideia de soberania popular e cidadania ativa (LEFEBVRE, 2001). Contudo, o processo colonial europeu impôs modelos de Estado que desconsideraram formas autônomas de organização de outros povos (TODOROV, 1993). Sociedades africanas e indígenas, por exemplo, desenvolveram sistemas de governança comunitária e participativa, como o *ubuntu* africano, que valoriza a interdependência e o bem comum (MBITI, 1990; TUTU, 1999). Apesar dos avanços democráticos, a história política revela recorrentes tentativas de exclusão da vontade popular, e, como observa BOBBIO (1986), persiste o paradoxo entre a promessa de igualdade política e sua efetiva realização.

No caso Brasileiro o processo de redemocratização, e a promulgação da Constituição de 1988 retomam o protagonismo da participação popular e tem com um de seus resultados a institucionalização dos Conselhos. O processo de redemocratização brasileira, iniciado na década de 1980, marcou uma ruptura com o regime autoritário instaurado em 1964 e representou um movimento social e político em defesa da ampliação dos direitos civis, sociais e políticos. Esse contexto histórico foi impulsionado por amplos setores da sociedade civil organizada, tais como sindicatos, movimentos populares, entidades religiosas, associações profissionais e acadêmicas, que reivindicavam não apenas o retorno das eleições diretas, mas também a construção de um novo pacto social baseado na cidadania e na participação popular (DAGNINO, 2004). No campo da saúde, o Movimento da Reforma Sanitária teve papel decisivo nesse processo, ao propor a saúde como um direito universal e um dever do Estado, rompendo com o modelo excludente e fragmentado vigente até então (PAIM, 2008).

A promulgação da Constituição Federal de 1988 consolidou as bases jurídicas da redemocratização e instituiu um novo paradigma de Estado e de cidadania no Brasil. Conhecida como “Constituição Cidadã”, ela ampliou os direitos sociais e introduziu o princípio da

participação social na formulação e no controle das políticas públicas. O artigo 1º, parágrafo único, estabelece que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” (BRASIL, 1988). No campo da saúde, o artigo 196 define que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”, devendo ser garantida mediante políticas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços. Esse marco constitucional foi decisivo para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), que passou a integrar, de forma descentralizada, as ações de saúde pública sob os princípios da universalidade, integralidade e equidade (BRASIL, 1988; PAIM, 2008).

Com a instituição do SUS, tornou-se necessário regulamentar os dispositivos constitucionais para viabilizar sua implementação. Assim, foram sancionadas a Lei nº 8.080/1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e a Lei nº 8.142/1990, que consolidaram o modelo de gestão participativa do sistema. A Lei nº 8.080/1990 definiu a estrutura e o funcionamento do SUS, estabelecendo diretrizes para a descentralização e a regionalização das ações de saúde (BRASIL, 1990). Já a Lei nº 8.142/1990 representou um avanço democrático fundamental ao criar os Conselhos e as Conferências de Saúde, instrumentos institucionais de controle social e de participação direta da população na formulação, execução e fiscalização das políticas públicas (BRASIL, 1990).

Os Conselhos de Saúde, previstos nessa legislação, tornaram-se espaços permanentes de deliberação colegiada e de articulação entre o Estado e a sociedade civil, atuando nas três esferas de governo: municipal, estadual e federal. A previsão de sua composição deve ser paritária, com 50% de representantes dos usuários, assegura o protagonismo da população nas decisões sobre prioridades, planos e recursos do SUS (BRASIL, 1990; LIMA, 2019). Essa estrutura reflete a materialização do princípio democrático inscrito na Constituição de 1988, que reconhece a participação popular como elemento essencial da gestão pública e da consolidação da cidadania.

Desse modo, a redemocratização brasileira não apenas restabeleceu direitos políticos, mas também promoveu uma transformação profunda na relação entre Estado e sociedade. A Constituição de 1988 e as leis orgânicas do SUS institucionalizaram a participação como princípio de governança, permitindo que a população atuasse na formulação e no controle das políticas públicas de saúde. Como observa GERSCHMAN (2004), a criação dos Conselhos de Saúde simboliza a passagem de um modelo tecnocrático e autoritário para um modelo

democrático e participativo, no qual o cidadão deixa de ser mero beneficiário e se torna sujeito ativo das decisões estatais. Assim, a experiência brasileira reafirma que a democracia se consolida não apenas pelo voto, mas pela efetiva presença da sociedade nos espaços de deliberação e controle das políticas públicas.

Não obstante ao processo de redemocratização do país, e ainda que a democracia seja um regime baseado na soberania do povo, a manutenção da soberania popular exige constante vigilância e aprofundamento. A ampliação dos mecanismos de participação direta, o fortalecimento da sociedade civil e o combate à desigualdade política são elementos centrais para a efetivação da democracia substantiva. Como conclui ROSANVALLON (2006), “a democracia do século XXI deverá ir além do voto, articulando novas formas de expressão e controle da vontade popular”. Apesar dos avanços nas últimas décadas a política brasileira pode ser compreendida a partir de um legado histórico marcado pelo patrimonialismo, clientelismo e autoritarismo, práticas que se enraizaram nas instituições e moldaram as relações entre Estado e sociedade. O patrimonialismo, herança da formação colonial e imperial, estabeleceu uma lógica em que a fronteira entre o público e o privado é difusa, permitindo a apropriação de recursos estatais para fins particulares. Essa prática fragiliza a construção de um Estado republicano voltado para o interesse coletivo, pois naturaliza a confusão entre poder político e privilégios pessoais. O clientelismo, por sua vez, perpetua relações de dependência e troca de favores entre governantes e governados, comprometendo a universalização de direitos sociais e subordinando a cidadania a vínculos pessoais e partidários. Já o autoritarismo se manifesta como traço recorrente de nossa trajetória política, tanto em regimes ditatoriais quanto em práticas de concentração de poder em contextos democráticos, restringindo a participação popular e limitando o exercício pleno da cidadania.

Sob uma perspectiva mais contemporânea a obra "Política social no Brasil (1964-2002): entre a cidadania e a caridade", de Eduardo Fagnani, analisa as transformações estruturais e ideológicas das políticas sociais brasileiras entre o período da ditadura militar e o início do século XXI. A tese central sustenta que, nesse intervalo, a política social oscilou entre um projeto de Estado de Bem-Estar Social, consolidado na Constituição de 1988, e o avanço de políticas neoliberais que resgataram a lógica da caridade e da focalização assistencialista. Durante o regime militar (1964-1985), a política social era autoritária, centralizada e limitada, com forte viés clientelista. A Constituição de 1988 representou uma virada institucional ao garantir direitos sociais universais, criando um marco legal voltado para a cidadania. No

entanto, a partir dos anos 1990, com a hegemonia do neoliberalismo, o Estado brasileiro passou por reformas que limitaram os direitos sociais e promoveram políticas focalizadas, desvinculadas do projeto de cidadania universal. A década de 1990 é marcada por reformas econômicas e sociais que priorizaram o equilíbrio fiscal, a redução dos gastos públicos e a responsabilização das famílias e organizações civis pela proteção social. Nesse contexto, direitos passaram a ser tratados como favores e programas filantrópicos, aprofundando desigualdades e fragilizando o modelo de proteção social universalista. Fagnani conclui que, apesar das conquistas institucionais promovidas pela Constituição de 1988, prevaleceu um modelo híbrido e contraditório de política social, oscilando entre cidadania e caridade, e dependente das escolhas macroeconômicas do Estado.

Esses elementos, ao se entrelaçarem, criam barreiras estruturais ao amadurecimento democrático no Brasil, uma vez que dificultam a consolidação de instituições transparentes, autônomas e voltadas à promoção do bem comum. Assim, compreender a persistência dessas práticas é essencial para pensar alternativas de fortalecimento da democracia, por meio da ampliação da participação social, da educação política e do aprimoramento dos mecanismos de controle e *accountability*. Cada uma dessas abordagens oferece contribuições sobre como o controle social influencia o desenvolvimento econômico, seja por meio da organização das instituições, da promoção da concorrência ou da transformação das relações de classe.

O desenvolvimento econômico, portanto, está diretamente relacionado à forma como a sociedade exerce o controle sobre suas instituições e seus indivíduos, seja de forma racional, democrática ou coercitiva. O controle social, entendido como o conjunto de mecanismos formais e informais que regulam comportamentos e instituições, exerce papel essencial no desenvolvimento econômico e na organização das políticas públicas, especialmente no campo da saúde, onde a tensão entre o público e o privado revela disputas ideológicas e estruturais. Para DURKHEIM (1893), o controle social é base da coesão e da solidariedade, fundamentais para a estabilidade social e, por extensão, para a efetividade de sistemas públicos de saúde. WEBER (1905) associa-o à racionalização e à burocracia, que garantem eficiência e previsibilidade às instituições, princípios que também sustentam a administração estatal moderna. Em contrapartida, MARX (1867) entende o controle social como instrumento de dominação das classes dominantes, o que, no contexto contemporâneo, pode ser observado nas políticas neoliberais que subordinam o direito à saúde à lógica do mercado. Já SMITH (1776) e RICARDO (1817), expoentes do liberalismo econômico, veem no livre mercado e na

competição mecanismos naturais de regulação e prosperidade, ideias retomadas pelo neoliberalismo ao defender a redução da intervenção estatal e a ampliação do setor privado na provisão de serviços de saúde. Essa perspectiva, contudo, gera tensões em sociedades que, como o Brasil, têm a saúde reconhecida constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado (BRASIL, 1988). Assim, o controle social, quando associado à participação popular e à regulação pública, torna-se elemento central para equilibrar as pressões do capital e a garantia da universalidade do acesso, reafirmando a primazia do interesse coletivo sobre a lógica mercantil.

A compreensão da saúde como bem público e direito social fundamental constitui um avanço decisivo na formulação das políticas públicas brasileiras. Essa concepção rompe com a visão restrita que associa saúde apenas à prestação de serviços médicos, reconhecendo que o processo saúde-doença resulta de um conjunto de fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais. Essa perspectiva rompe com o paradigma biomédico tradicional e insere a saúde no campo das políticas sociais, reconhecendo a influência de fatores econômicos, ambientais e culturais sobre as condições de vida da população. Esse entendimento é central na Saúde Coletiva, campo interdisciplinar que analisa a saúde como fenômeno socialmente determinado, vinculado às condições de vida e às desigualdades estruturais (BREILH, 2006; BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007).

A partir dessa perspectiva, consolida-se o conceito de Determinação Social da Saúde, segundo o qual as condições de saúde de uma população não dependem apenas da disponibilidade de serviços, mas também da distribuição de renda, da qualidade do trabalho, da educação, do saneamento básico e do meio ambiente. Assim, políticas econômicas, sociais e territoriais são, simultaneamente, determinantes e condicionantes da saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2008) reforça que a melhoria dos indicadores sanitários está intrinsecamente ligada à redução das desigualdades sociais, o que exige uma ação intersetorial e uma abordagem de equidade.

No caso brasileiro, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi concebido justamente para enfrentar essas desigualdades, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços. Entretanto, nas regiões de menor dinamismo econômico, como o Norte de Minas Gerais, persistem iniquidades estruturais que limitam a efetividade das políticas públicas. Estudos regionais demonstram que a desigualdade na oferta de serviços, a precariedade das condições de

saneamento e a baixa densidade de profissionais de saúde são fatores que ampliam a vulnerabilidade social e comprometem o princípio da equidade (MELO; SANTOS; SANTOS, 2021).

Dessa forma, compreender a saúde como bem público implica reconhecer que sua efetivação depende de políticas integradas que enfrentem as causas sociais da doença e da exclusão. Para o Norte de Minas Gerais, essa leitura é particularmente relevante, uma vez que o território apresenta um histórico de desinvestimento público, baixa capacidade de gestão municipal e dependência econômica de transferências federais, elementos que refletem e reforçam as desigualdades regionais. A efetividade dos Conselhos Municipais de Saúde, nesse contexto, deve ser analisada não apenas pela sua dimensão institucional, mas também como instrumento de participação cidadã e democratização das decisões públicas, condição indispensável para reduzir as iniquidades e concretizar o direito universal à saúde.

A trajetória do Sistema Único de Saúde (SUS) também é marcada pelo conflito entre o princípio da universalidade, que garante o acesso igualitário e gratuito à saúde, e a presença consolidada do setor privado na oferta e no financiamento dos serviços. Desde sua criação, o SUS convive com um modelo onde coexistem o sistema público universal e um sistema suplementar privado, composto por operadoras de planos de saúde e prestadores contratados. Essa dualidade expressa não apenas uma herança histórica, mas também uma disputa contínua sobre o papel do Estado e o alcance dos direitos sociais no Brasil (BRAVO; CORREIA, 2012).

Com a ascensão das políticas neoliberais a partir da década de 1990, intensificou-se o processo de privatização indireta da saúde, por meio da terceirização de serviços e da crescente dependência do SUS em relação à rede privada conveniada. Tal dinâmica reflete uma tendência global de redução da intervenção estatal e de expansão do mercado em setores sociais, o que compromete a capacidade redistributiva e a equidade do sistema, nesse contexto, a Emenda Constitucional nº 95/2016, conhecida como Teto de Gastos, impôs severas restrições ao financiamento da saúde pública, ao congelar por vinte anos os investimentos federais em despesas primárias. O conflito entre o público e o privado no setor saúde também se manifesta nas disputas por recursos orçamentários e nas tensões em torno da lógica de mercado que permeia a gestão de serviços públicos. Enquanto o SUS é orientado por princípios de solidariedade e universalidade, o setor suplementar opera segundo a racionalidade empresarial, priorizando a capacidade de pagamento e a rentabilidade dos serviços. Essa contradição

aprofunda desigualdades regionais e de classe, sobretudo em áreas periféricas, como o Norte de Minas Gerais, onde a cobertura dos planos privados é restrita e o SUS é o principal provedor de cuidados

Desse modo, compreender a efetividade dos Conselhos Municipais de Saúde nessa região exige considerar esse contexto de subfinanciamento e assimetria estrutural. A atuação dos conselhos não pode ser analisada apenas sob o prisma institucional, mas também político e econômico: trata-se de espaços de resistência democrática frente à mercantilização da saúde e à retração do Estado. Assim, discutir o conflito público-privado é essencial para compreender os limites e potencialidades do controle social como instrumento de defesa do direito universal à saúde.

4.1. OS CONSELHOS PROPRIAMENTE DITOS

Também é essencial compreender o papel dos conselhos de políticas públicas, que são instituídos como instâncias de controle e participação social. Segundo TATAGIBA (2002, p. 47), os conselhos gestores são concebidos como espaços em que a sociedade exerce um papel mais efetivo de fiscalização e controle, ao estar mais próxima do Estado. Além disso, esses espaços permitem uma maior democratização no processo de definição de prioridades, especialmente na alocação de recursos públicos. A autora destaca que esses mecanismos de participação forçam o Estado a negociar suas propostas com diferentes grupos sociais que, muitas vezes, já exercem influência sobre o poder estatal. TATAGIBA (2002) também aponta que se espera que a participação social tenha um efeito educacional direto sobre os próprios atores envolvidos, promovendo a cidadania e fortalecendo a democracia.

A sociedade poderia exercer um papel mais efetivo de fiscalização e controle estando mais próxima do Estado, assim como poderia imprimir uma lógica mais democrática na definição da prioridade na alocação dos recursos públicos. Esses mecanismos de participação obrigariam o Estado a negociar suas propostas com outros grupos sociais que circulam em torno do poder estatal e costumam exercer influência direta sobre ele. Esperava-se ainda, que a participação tivesse um efeito direto sobre os próprios atores que participavam, atuando, assim, como um fator educacional na promoção da cidadania. (TATAGIBA,2002)

TATAGIBA (2002) aponta que os conselhos gestores são espaços de democratização e de controle social, onde a sociedade pode influenciar as decisões do Estado, sendo, assim, uma

forma de educação política e cidadã. Sua proposta envolve um controle que vai além da fiscalização, afetando diretamente a forma como os recursos são alocados e como as políticas públicas são formuladas.

Os conselhos de políticas públicas são instâncias colegiadas, com caráter permanente e deliberativo, que têm a missão de atuar na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas públicas. Como estabelece o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 8142/90, os conselhos devem não apenas formular as diretrizes das políticas de saúde (por exemplo), mas também acompanhar sua execução, incluindo seus aspectos econômicos e financeiros. De acordo com o CONASEMS (1995, p. 23), o caráter deliberativo do conselho pressupõe uma atuação constante, permitindo que seus membros examinem e aprovem as diretrizes, aperfeiçoem estratégias e proponham ajustes ou correções, quando necessário. Isso reforça a ideia de que o controle social deve ser contínuo e não apenas episódico, como uma mera formalidade legal.

Atuar na formulação de estratégias da política de saúde, e no controle da execução da política de saúde, incluindo seus aspectos econômicos e financeiros. O caráter deliberativo do Conselho não admite que funcione somente quando convocado, mas pressupõe uma atuação constante para que seus membros tenham condições de examinar e aprovar as diretrizes da política de saúde, formulando estratégias, aperfeiçoando-as e propondo meios aptos para a sua execução ou correção de rumos (CONASEMS, 1995:23).

No entanto, como salienta DI PIETRO (2015, p. 881), o controle administrativo, quando exercido pela administração pública, deve ser entendido como o poder de fiscalização e correção que a própria administração exerce sobre sua atuação. No caso dos conselhos de políticas públicas, o controle social independe da discricionariedade da administração pública, o que assegura a liberdade e autonomia dos conselhos em sua atuação. Esse tipo de controle é essencial para garantir a transparência e a responsabilidade no processo de implementação das políticas públicas.

DI PIETRO (2015) define o controle administrativo como o poder de fiscalização exercido pela administração pública sobre suas próprias ações, destacando a autonomia dos conselhos de políticas públicas em exercer o controle social, independente da discricionariedade do poder público.

Além dos estudos teóricos que fundamentam a compreensão dos conselhos e do controle social,

é importante considerar os desafios específicos encontrados em contextos regionais como o da Região Norte de Minas Gerais. De acordo com SANTOS (2021), a implementação efetiva dos conselhos de políticas públicas enfrenta dificuldades em regiões periféricas devido à fragilidade das instituições locais e à escassez de recursos. Santos argumenta que, embora os conselhos estejam formalmente instituídos, sua efetividade muitas vezes é comprometida pela falta de capacitação dos atores locais e pela pouca integração entre os conselhos e a administração pública.

FERREIRA E COSTA (2022) ampliam essa análise, destacando que, na Região Norte de Minas, as dificuldades de infraestrutura e a desigualdade social comprometem a capacidade de participação da população nos conselhos de políticas públicas. Os autores afirmam que as condições locais tornam difícil o funcionamento eficaz desses conselhos, além de limitarem o impacto que poderiam ter na implementação e monitoramento das políticas públicas.

SANTOS (2021) examina as dificuldades enfrentadas pelos conselhos de políticas públicas em regiões periféricas, como o Norte de Minas Gerais, onde as condições de institucionalidade e recursos limitados dificultam a implementação eficaz desses mecanismos de participação social.

FERREIRA E COSTA (2022) discutem como as deficiências de infraestrutura e a desigualdade social na Região Norte de Minas Gerais comprometem a capacidade de os conselhos atuarem efetivamente na formulação e controle das políticas públicas, resultando em uma participação social muitas vezes ineficaz.

Assim, os conselhos de políticas públicas, em teoria, são instrumentos eficazes para promover a democracia participativa e o controle social. No entanto, a efetividade de sua atuação depende de vários fatores, como a capacitação dos participantes, a integração com a administração pública e as condições locais, que variam significativamente entre as diferentes regiões do Brasil. A análise dos conselhos na Região Norte de Minas Gerais revela a necessidade de abordagens específicas que considerem as limitações estruturais e sociais da região, a fim de garantir que esses espaços de participação cumpram seu papel na promoção da cidadania e na melhoria da gestão pública.

5. INSTITUIÇÕES FORTES E CONTROLE SOCIAL: IMPLICAÇÕES PARA O DESEMPENHO ECONÔMICO

As instituições desempenham um papel central no desenvolvimento econômico, moldando as interações entre os agentes econômicos e criando o ambiente propício para o crescimento sustentável. Instituições fortes são aquelas que possuem regras claras, são eficientes em sua execução e garantem a justiça e a segurança jurídica. No entanto, para que essas instituições funcionem adequadamente, elas precisam ser sujeitas ao controle social, ou seja, à fiscalização e participação ativa da população. O controle social, exercido através de auditorias, transparência e participação cidadã, é fundamental para garantir que as instituições operem de maneira responsável, eficiente e transparente.

A importância das instituições para o desempenho econômico foi amplamente discutida por Douglass North (1990), um dos principais teóricos da economia institucional. North argumenta que as instituições moldam os incentivos dos agentes econômicos e determinam o ambiente no qual as transações econômicas ocorrem. Em seu trabalho, ele afirma que instituições fracas geram incertezas e custos adicionais, prejudicando o desempenho econômico. Já as instituições fortes, que são transparentes e eficazes, proporcionam um ambiente mais estável, onde os agentes econômicos têm confiança para investir e realizar negócios. O controle social, por sua vez, garante que as instituições não se desviem de seus objetivos e operem de maneira eficaz, o que resulta em um melhor desempenho econômico.

O artigo “As influências norte-americanas de Roberto Simonsen: Controle social, institucionalismo e planejamento”, segundo CAVALIERI E CURADO (20216) analisa as influências teóricas e institucionais do pensamento norte-americano na obra de Roberto Simonsen, destacando sua incorporação do institucionalismo e da filosofia do controle social. Os autores mostram como Simonsen, especialmente durante a década de 1940, se valeu das ideias de pensadores como Stuart Chase, Rexford Tugwell e outros associados ao New Deal, para defender o planejamento econômico como instrumento legítimo de organização racional da economia brasileira. Em oposição ao liberalismo clássico de Eugênio Gudin, Simonsen propôs uma visão de planejamento que integrava ciência, técnica e valores sociais, inspirado nas discussões sobre economia institucional e no papel do Estado como promotor do bem-estar coletivo. Seu projeto intelectual esteve fortemente ligado ao desenvolvimento da Escola Livre

de Sociologia e Política e à recepção de ideias norte-americanas que valorizavam a regulação econômica como resposta aos desafios da industrialização e da justiça social. O artigo destaca que a defesa do planejamento por Simonsen não representava autoritarismo, mas uma tentativa de compatibilizar democracia com intervenção estatal racional, técnica e moralmente fundamentada.

A contribuição de Elinor Ostrom (1990) também é essencial para entender o papel do controle social nas instituições econômicas. Em seu estudo sobre a gestão de bens comuns, Ostrom demonstrou que as comunidades podem gerenciar seus próprios recursos de maneira eficiente, sem depender da intervenção do governo ou do mercado. A autora destaca que, quando as comunidades têm a oportunidade de participar ativamente da gestão e fiscalização das instituições, o desempenho econômico tende a ser mais sustentável. Isso reforça a ideia de que o controle social não apenas melhora a eficiência das instituições, mas também assegura que os recursos sejam alocados de maneira justa e equitativa.

O controle social, na forma de auditorias e participação cidadã, também ajuda a reduzir práticas como a corrupção e a ineficiência dentro das instituições econômicas. James Buchanan (1962), em sua teoria da escolha pública, argumenta que as instituições econômicas são moldadas por escolhas feitas por indivíduos que agem de acordo com seus próprios interesses. Para que as instituições sirvam ao bem coletivo, elas precisam ser constantemente verificadas pela sociedade. O controle social, então, torna-se um mecanismo essencial para corrigir falhas de mercado e garantir que as decisões econômicas atendam ao interesse público.

A teoria de Michel Foucault (1975), embora mais voltada para o campo da sociologia, pode contribuir para a análise do controle social nas instituições econômicas. Foucault argumenta que o poder nas sociedades modernas é exercido não apenas por meio de regras formais, mas também por mecanismos de vigilância e disciplina. No contexto econômico, isso significa que o controle social, exercido por meio de auditorias e fiscalização pública, pode ajudar a evitar comportamentos desviantes, como a corrupção, e garantir que as instituições cumpram suas funções adequadamente.

Exemplos práticos de países que aplicam o controle social de forma eficaz ilustram como instituições fortes podem ter um impacto positivo no desempenho econômico. Países como Suécia, Noruega e Dinamarca, conhecidos por sua governança transparente, têm sistemas de fiscalização pública robustos, onde a participação da população nas decisões políticas e

econômicas é incentivada. Esses países possuem altos índices de confiança nas instituições, o que contribui para o crescimento econômico sustentável e a redução das desigualdades. Cingapura, por sua vez, é um exemplo de um país onde a implementação de políticas rigorosas de auditoria e fiscalização pública resultou em uma das economias mais competitivas do mundo. Esses exemplos demonstram que quando as instituições são fortes e verificadas pelo controle social, o desempenho econômico tende a ser mais positivo e estável.

Portanto, podemos concluir que instituições fortes, aliadas a mecanismos de controle social, têm um impacto direto e positivo no desempenho econômico. O controle social, exercido através da fiscalização e da participação cidadã, ajuda a reduzir a corrupção, aumenta a transparência e melhora a alocação de recursos. Ao garantir que as instituições operem de maneira eficiente e responsável, o controle social contribui para o crescimento econômico e para a estabilidade das economias. A interação entre governança sólida e controle social cria um ciclo virtuoso, no qual o bom desempenho econômico fortalece as instituições, promovendo uma sociedade mais próspera, justa e estável.

6. ESTUDOS AFINS

O presente trabalho reverbera pesquisas em que o tema tratado foi abordado em contextos similares ao proposto, como no caso do artigo de STRALEN et al. (2006) que analisa a efetividade da participação dos Conselhos Municipais de Saúde na gestão das políticas públicas em municípios de Goiás e Mato Grosso do Sul, especialmente em relação à reestruturação da atenção básica via Estratégia de Saúde da Família. A partir da análise de legislação, documentos institucionais e entrevistas com conselheiros, os autores observam que, embora os conselhos sejam importantes instâncias de controle social e legitimem decisões no âmbito do SUS, sua influência efetiva na reorganização dos serviços de saúde permanece limitada. No trabalho dos autores conclui-se que os conselhos ampliam a participação social, mas enfrentam obstáculos institucionais e políticos que reduzem seu impacto direto na formulação e implementação das políticas de saúde.

Já o estudo de Zambon e Ogata (2013) investiga, por meio de entrevistas qualitativas com conselheiros municipais de saúde em São Paulo, as percepções sobre o controle social no SUS. Os resultados mostram que há concepções divergentes sobre o papel do conselho, desde entendimentos alinhados à função deliberativa até interpretações distorcidas do conceito de controle social. Destacam-se dificuldades como a centralização das decisões pela gestão, valorização excessiva do saber técnico e ausência de conferências municipais. Conclui-se que, apesar dos avanços, ainda há fragilidades na formação e atuação dos conselheiros, reafirmando a importância da educação permanente em saúde para fortalecer o controle social e a democracia participativa no âmbito local.

Para Farias Filho, Silva e Mathis (2014) que analisam a ação coletiva em conselhos municipais de saúde da Região Metropolitana de Belém, utilizando levantamento documental, entrevistas e observação. A pesquisa identificou que, embora os conselhos representem instâncias de participação e controle social, suas práticas são marcadas por cooptação de conselheiros, definição de pautas pela gestão e predominância de interesses individuais sobre os coletivos. O estudo conclui que tais dinâmicas contrariam os princípios do SUS e fragilizam a legitimidade dos conselhos, evidenciando limites estruturais e culturais da ação coletiva e apontando a necessidade de maior autonomia e fortalecimento da dimensão pública desses espaços.

Landerdhal et al. (2010) realizam análise documental de resoluções registradas em atas de um Conselho Municipal de Saúde no Rio Grande do Sul, buscando compreender se tais atos expressam efetivo controle social. Os resultados apontam que a maioria das resoluções refere-se à aprovação de programas e projetos encaminhados pela gestão, especialmente sobre infraestrutura e serviços, revelando caráter predominantemente burocrático. Não foram identificadas deliberações autônomas ou propositivas originadas do conselho, o que indica que o mero funcionamento formal não garante participação qualificada. Conclui-se que há um distanciamento entre o potencial dos conselhos e sua prática, reforçando a necessidade de ampliar sua capacidade deliberativa.

O artigo de Rosângela Minardi Mitre Cotta et al. (2011), publicado na *Revista Physis*, analisa a experiência de controle social exercido por um Conselho Municipal de Saúde (CMS) em um município de pequeno porte em Minas Gerais, evidenciando fragilidades estruturais e políticas que comprometem o exercício da participação popular no Sistema Único de Saúde (SUS). Ainda que legalmente previsto pela Lei nº 8.142/90 como instância deliberativa e estratégica, o CMS se mostra, na prática, esvaziado de sua função democrática, funcionando como um espaço formalizado, mas carente de representatividade, autonomia e eficácia.

A pesquisa revelou que a composição do conselho desrespeita o princípio da paridade exigido por lei, com predominância de membros vinculados à prefeitura e ao poder político local. Essa configuração compromete a autonomia dos conselheiros, que, em sua maioria, desconhecem suas atribuições e o papel do conselho. As reuniões são esporádicas edesorganizadas, o que reforça a percepção de que o CMS atua apenas para homologar decisões previamente tomadas pela gestão municipal. Muitos conselheiros relataram medo de se posicionar por receio de represálias políticas ou administrativas, enquanto outros reconhecem sua participação apenas como simbólica ou burocrática. A prática participativa vivenciada se distancia dos ideais constitucionais de cidadania ativa e controle social. O artigo evidencia que a ingerência política no processo de escolha e atuação dos conselheiros, somada à baixa capacitação e engajamento dos membros, inviabiliza a consolidação do conselho como espaço real de deliberação e transformação social. Essa realidade é reflexo de uma cultura política marcada pelo patrimonialismo, clientelismo e autoritarismo — elementos que historicamente impedem o amadurecimento democrático no Brasil. O estudo confirma que a simples existência de espaços institucionais de participação não garante, por si só, a efetividade do controle social. Para que esse controle seja exercido de forma legítima e eficiente, é necessário investir na formação política dos conselheiros, promover a autonomia das instituições locais e combater práticas políticas excludentes. O desenvolvimento social e econômico, como demonstram autores

clássicos e contemporâneos, está diretamente relacionado à qualidade das instituições e à capacidade dos cidadãos de exercerem seus direitos de forma plena e consciente. Sem uma cultura de participação efetiva e um Estado comprometido com a democratização do poder, o controle social continuará sendo uma formalidade vazia, distante de seu papel transformador.

7. A GOVERNANÇA, O PLANEJAMENTO E OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NO SUS: O PAPEL FUNDAMENTAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

Os instrumentos de gestão no Sistema Único de Saúde (SUS) são mecanismos fundamentais para o planejamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas de saúde. Esses instrumentos são garantidores do princípio da transparência na aplicação dos recursos e da eficiência na prestação de serviços. A efetividade do SUS está intrinsecamente ligada à articulação entre governança, planejamento e instrumentos de gestão, sendo que a participação dos Conselhos Municipais de Saúde (CMS) representa um pilar essencial nesse processo. Esses conselhos, compostos de forma paritária por representantes do governo, profissionais de saúde e usuários do sistema, exercem um papel deliberativo e fiscalizador, garantindo que as políticas públicas reflitam as reais necessidades da população e os princípios constitucionais do SUS.

Entre os principais instrumentos de planejamento do SUS, destaca-se o Plano de Saúde, um documento estratégico que define as diretrizes, metas e prioridades para a gestão da saúde em um período de quatro anos. Complementar a ele, a Programação Anual de Saúde detalha as ações e serviços de saúde a serem executados anualmente, alinhando-se ao planejamento estratégico. O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior é um instrumento de monitoramento que apresenta os avanços e desafios da execução das ações previstas na Programação Anual de Saúde, permitindo ajustes na gestão. Já o Relatório Anual de Gestão sintetiza as ações e resultados alcançados ao longo do ano, funcionando como um mecanismo de prestação de contas que reforça a transparência e o controle social.

Esses instrumentos possuem relação direta com os instrumentos de planejamento governamental, como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). O Plano de Saúde, por exemplo, deve estar alinhado ao PPA, enquanto a Programação Anual de Saúde segue as metas estabelecidas na LDO e LOA. Os relatórios de gestão servem como ferramentas de prestação de contas e avaliação, permitindo que os CMS acompanhem a execução física e financeira das ações planejadas.

A governança no SUS ganha força e legitimidade por meio da atuação dos Conselhos Municipais de Saúde, que não apenas acompanham a execução das ações de saúde, mas também participam ativamente da formulação de políticas, como na elaboração do Plano Municipal de Saúde e na aprovação da Programação Anual de Saúde. Em Minas Gerais, por exemplo, os

Conselhos Municipais de Saúde desempenham um papel fundamental no funcionamento das Comissões Intergestores Bipartite, trazendo para o debate as demandas locais e influenciando diretamente as pactuações regionais. Além disso, esses conselhos são responsáveis por analisar e aprovar o Relatório Anual de Gestão, reforçando a transparência e o controle social.

A plataforma DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento (DGMP), mantida pelo Ministério da Saúde, facilita o registro e acompanhamento desses instrumentos, permitindo que estados e municípios acompanhem o status de seus planejamentos de maneira sistemática. A importância desse acompanhamento é evidenciada pelos dados disponibilizados na plataforma, que mostram a quantidade de documentos aprovados, em análise ou em processo de elaboração. Em Minas Gerais, por exemplo, entre 2016 e 2025, os dados quantitativos demonstram a amplitude do planejamento na saúde, com 1.631 Planos de Saúde aprovados, 8 pactuações homologadas pelo gestor estadual e 5.628 Programações Anuais de Saúde aprovadas. No que se refere ao Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior, foram avaliados 4.473 documentos no primeiro quadrimestre, 4.377 no segundo e 4.029 no terceiro. Além disso, o Relatório Anual de Gestão contou com 4.115 aprovações. A análise contínua dos Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior, que somam mais de 12 mil avaliações ao longo do ano, permite ajustes rápidos para melhor atender às necessidades da população. A transparência no planejamento também é um aspecto essencial para fortalecer a participação popular. Os conselhos de saúde têm papel ativo na avaliação e aprovação dos instrumentos de planejamento, garantindo que as políticas sejam construídas de forma democrática e alinhadas às necessidades locais.

A integração entre governança, planejamento e instrumentos de gestão só alcança seu potencial máximo quando os Conselhos Municipais de Saúde estão fortalecidos e atuantes. Esses conselhos não apenas legitimam as decisões tomadas pelos gestores, mas também garantem que a voz da população seja ouvida em todas as etapas do processo. Para que o SUS continue avançando em direção a um sistema mais equitativo e resolutivo, é essencial investir na capacitação dos conselheiros, na estruturação dos Conselhos Municipais de Saúde e na democratização das informações. Afinal, como previsto na Constituição de 1988, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, mas também uma responsabilidade compartilhada com a sociedade.

O quadro a seguir apresenta as principais legislações que instituem e regulamentam os instrumentos de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), com destaque para o Plano de Saúde, a Programação Anual de Saúde (PAS) e o Relatório Anual de Gestão (RAG).

Instrumento de Gestão	Legislação/Norma	Artigos/Dispositivos Principais	Conteúdo/Exigência	Relação com o Instrumento
Plano de Saúde	Constituição Federal de 1988	Art. 196 a 200	Define a saúde como direito de todos e dever do Estado; estabelece a organização do SUS e a necessidade de planejamento público.	Fundamenta o dever estatal de planejar ações e políticas de saúde.
Plano de Saúde	Lei nº 8.080/1990	Art. 36	Determina que o processo de planejamento e orçamento do SUS deve ser ascendente, integrado e participativo.	Obriga a elaboração do Plano de Saúde em todos os níveis de gestão.
Plano de Saúde	Decreto nº 7.508/2011	Capítulo IV (arts. 36 a 41)	Regulamenta o planejamento da saúde, estabelecendo que o Plano é o instrumento central do processo de gestão.	Define o conteúdo mínimo e a integração do Plano com o PPA.
Plano de Saúde	Portaria MS nº 2.135/2013	Arts. 2º e 3º	Institui as diretrizes para o processo de planejamento no SUS. O Plano de Saúde deve ter vigência de quatro anos e orientar a PAS e o RAG.	Estabelece o formato, vigência e relação entre os instrumentos.
Plano de Saúde	Resolução CNS nº 453/2012	Art. 1º, inciso V	Determina que o Plano de Saúde deve ser submetido à apreciação e aprovação do Conselho de Saúde.	Garante o controle social e a transparência do instrumento.
Programação Anual de Saúde (PAS)	Lei nº 8.080/1990	Art. 36, §1º	Prevê o desdobramento anual do planejamento em metas e ações específicas.	Base legal para a PAS como detalhamento operacional do Plano de Saúde.
Programação Anual de Saúde (PAS)	Portaria MS nº 2.135/2013	Arts. 4º e 5º	Define a PAS como instrumento anual de operacionalização do Plano de Saúde, vinculada à LDO e à LOA.	Estabelece que cada gestor deve elaborar e submeter a PAS anualmente.
Programação Anual de Saúde (PAS)	Resolução CNS nº 453/2012	Art. 1º, inciso V	Determina a apreciação e aprovação da PAS pelos Conselhos de Saúde.	Assegura o acompanhamento social e a legitimidade da gestão.

Relatório Anual de Gestão (RAG)	Lei nº 8.142/1990	Art. 1º, §2º	Estabelece que a execução e os resultados das ações e serviços devem ser apresentados em relatórios de gestão.	Base legal para o RAG como instrumento de prestação de contas.
Relatório Anual de Gestão (RAG)	Decreto nº 7.508/2011	Art. 41	Determina que os resultados do Plano e da PAS devem ser consolidados no Relatório de Gestão.	Integra o RAG ao ciclo de planejamento e avaliação.
Relatório Anual de Gestão (RAG)	Portaria MS nº 2.135/2013	Art. 6º	Define o RAG como instrumento anual de monitoramento e avaliação da execução da PAS.	Obriga a elaboração e envio do RAG ao Conselho de Saúde e aos órgãos de controle.
Relatório Anual de Gestão (RAG)	Resolução CNS nº 453/2012	Art. 1º, inciso V	O RAG deve ser apreciado e aprovado pelo Conselho de Saúde.	Garante o controle social e a transparência na gestão do SUS.

7.1 HIERARQUIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO NO SUS: FUNDAMENTOS E FUNCIONAMENTO NAS ESFERAS DE PODER

A hierarquização e descentralização no Sistema Único de Saúde (SUS) são princípios organizativos fundamentais para garantir o acesso universal, igualitário e integral à saúde no Brasil. Ambos os conceitos estão entre os pilares definidos pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), sendo essenciais para a construção de um sistema público eficiente e equitativo. A hierarquização se refere à organização dos serviços de saúde em níveis crescentes de complexidade, se estendendo da atenção básica até a alta complexidade, garantindo um fluxo racional e resolutivo do cuidado. Segundo a Lei nº 8.080/1990, a hierarquização visa “organizar a rede de serviços de saúde em níveis de complexidade crescente” (BRASIL, 1990).

Esse princípio orienta a estruturação da atenção em três níveis principais: **Atenção Primária:** porta de entrada preferencial do sistema, com foco em ações preventivas, promocionais, curativas e de reabilitação. Representa a maior parcela da resolutividade dos problemas de saúde da população. **Atenção Secundária:** composta por serviços ambulatoriais especializados e hospitalares de média complexidade. **Atenção Terciária:** envolve serviços de alta complexidade tecnológica, como unidades de terapia intensiva, cirurgias especializadas e

procedimentos de alto custo. A lógica da hierarquização favorece a integralidade do cuidado, na medida em que permite a continuidade e a coordenação das ações em todos os níveis. “A hierarquização é o princípio organizativo que permite racionalizar recursos e garantir maior eficiência e equidade no acesso aos serviços” (SILVA & PEREIRA, 2016, p. 89).

A descentralização refere-se à transferência de responsabilidades da gestão e execução das ações de saúde da esfera federal para os estados e, sobretudo, para os municípios. Esse processo tem como base o Art. 198 da Constituição Federal, que afirma que as ações e serviços públicos de saúde são organizados em uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, “descentralizado, com direção única em cada esfera de governo” (BRASIL, 1988). A descentralização promove a autonomia dos entes federativos para planejamento, gestão e execução dos serviços, além de conferir maior capilaridade das políticas públicas, aproximando-as das realidades locais. Permite agilidade na tomada de decisões e na alocação de recursos e assegura a participação social por meio dos conselhos e conferências de saúde. Segundo Lima et al. (2006), a descentralização no SUS não é apenas administrativa, mas também política, ao estimular o controle social e a corresponsabilização dos gestores locais. “A descentralização do SUS constitui uma estratégia para ampliar o acesso, respeitar as diversidades regionais e fortalecer a governança local da saúde” (VIEIRA; SANTOS, 2011, p. 34).

7.2 FUNCIONAMENTO NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

O SUS se organiza em um modelo tripartite, no qual as três esferas de governo; federal, estadual e municipal; compartilham responsabilidades de forma complementar. A esfera Federal, União, por meio do Ministério da Saúde, é responsável por: Formular políticas nacionais de saúde; Coordenar programas estratégicos; Estabelecer diretrizes e normas técnicas; Financiar parte significativa das ações e serviços; Promover a regulação e avaliação do sistema em todo o país. “Compete à União formular políticas nacionais de saúde, com vistas à promoção, proteção e recuperação da saúde em todo o território nacional” (BRASIL, 1990, Art. 16).

A esfera Estadual atua como elo intermediário entre o governo federal e os municípios, com atribuições como: Coordenar redes regionais de saúde; Planejar e implementar políticas estaduais de saúde; Ofertar serviços de média e alta complexidade; Apoiar tecnicamente os

municípios.

A esfera Municipal é a principal executora das ações de saúde no território, com responsabilidade sobre: Gestão da atenção básica; Coordenação da rede de serviços locais; Promoção da saúde, vigilância epidemiológica e sanitária; Contratação e supervisão de profissionais da saúde.

A organização do SUS obedece ao princípio da direcionalidade única, segundo o qual cada esfera de governo deve manter uma instância diretiva do sistema. Essa estrutura é operacionalizada por meio de instâncias deliberativas e normativas, tais como: Comissão Intergestores Tripartite (CIT); Comissões Intergestores Bipartites (CIBs); Conselhos de Saúde. “O Decreto nº 7.508 regulamenta a organização do SUS por meio da regionalização, da definição dos contratos organizativos da ação pública da saúde e do funcionamento das redes de atenção” (BRASIL, 2011).

7.3 PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO – PDR

O Plano Diretor de Regionalização (PDR-SUS/MG) é o principal instrumento de organização territorial da saúde pública no estado de Minas Gerais. Seu objetivo é promover a regionalização dos serviços de saúde, organizando o acesso da população conforme a complexidade da assistência necessária e a capacidade instalada dos municípios. O mapa apresentado refere-se à Macrorregião de Saúde Norte de Minas, que é uma das 14 macrorregiões em que o território mineiro foi dividido para fins de planejamento e prestação dos serviços de saúde.

Essa macrorregião abrange diversos municípios do norte do estado e está subdividida em microrregiões de saúde, que funcionam como agrupamentos locais com estrutura suficiente para atender à média complexidade, como consultas especializadas, exames e internações clínicas. Já os atendimentos de alta complexidade, como cirurgias especializadas e tratamentos oncológicos, estão concentrados em polos macrorregionais, como Montes Claros, que é o principal centro de referência da macrorregião Norte. O funcionamento do PDR ocorre de forma integrada nas esferas municipal, estadual e federal. Os municípios são os responsáveis diretos pela atenção primária e pela gestão dos serviços locais, devendo seguir os critérios e pactuações estabelecidas no plano regional. O estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde e suas Superintendências Regionais (como a SRS de Montes Claros), coordena a

A regionalização da saúde também é organizada conforme o poder público, em suas competências constitucionais: o Poder Executivo elabora, pactua e executa as ações de saúde via secretarias municipais e estadual; o Poder Legislativo acompanha e fiscaliza os planos de saúde, aprova orçamentos e incentiva o controle social; e o Poder Judiciário, quando acionado, garante o cumprimento do direito à saúde. Portanto, o PDR organiza todo o funcionamento do SUS em Minas Gerais por meio de um planejamento territorial que reconhece as particularidades regionais e promove um sistema mais eficiente e equitativo. A Macrorregião Norte de Minas, representada no mapa, é um exemplo desse esforço de integração regional, contando com municípios estruturados para atender diferentes níveis de complexidade, com pactuações contínuas entre os entes federados e orientações normativas que visam garantir o acesso integral à saúde para toda a população.



Para fins deste estudo a delimitação da microrregião de saúde e de suas sedes para análise ocorrerá como se segue:

A microrregião de saúde é uma das instâncias de organização do Sistema Único de Saúde (SUS), instituída com base nos princípios da regionalização e da hierarquização da atenção à saúde. De acordo com a Portaria nº 4.279/2010 do Ministério da Saúde, a regionalização visa garantir o acesso integral, equânime e contínuo aos serviços de saúde, por meio da integração dos municípios em territórios delimitados segundo critérios geográficos, econômicos, culturais e de fluxos assistenciais. Assim, a sede da microrregião de saúde é o município de referência responsável por concentrar serviços de maior complexidade e coordenar as ações intermunicipais no território, funcionando como polo administrativo, técnico e assistencial.

No caso da Região Norte de Minas Gerais, o planejamento regional de saúde é estruturado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) por meio das Superintendências Regionais de Saúde (SRS) e das Gerências Regionais de Saúde (GRS). Dentro dessa divisão, destacam-se microrregiões como as de Montes Claros e Francisco Sá, ambas sob a jurisdição da SRS de Montes Claros.

Para fins desta pesquisa, serão analisadas especificamente as microrregiões de Montes Claros e Francisco Sá, tendo em vista sua relevância estratégica e suas particularidades socioeconômicas e sanitárias. Montes Claros é reconhecida como o principal polo urbano e de serviços da região Norte de Minas, concentrando hospitais de média e alta complexidade, instituições de ensino superior e a sede da própria Superintendência Regional de Saúde. Já Francisco Sá foi selecionada por representar uma microrregião com características predominantemente rurais e menor densidade populacional, permitindo um contraponto analítico em relação à estrutura mais consolidada de Montes Claros.

Essa escolha possibilita uma análise comparativa entre uma microrregião de forte centralidade e outra de menor porte, favorecendo a compreensão das desigualdades regionais na organização e no funcionamento do sistema de saúde, bem como das estratégias de gestão adotadas pelos respectivos Conselhos Municipais de Saúde (CMS).

8. METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem qualitativa, fundamentada na pesquisa documental como principal estratégia metodológica. Segundo Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), a pesquisa documental busca produzir novos conhecimentos a partir do exame de materiais originais, sejam eles analisados pela primeira vez ou reinterpretados em conformidade com os objetivos da investigação. Essa abordagem permite compreender fenômenos sociais complexos, especialmente em contextos onde o comportamento humano e os processos participativos estão em análise, como no caso dos conselhos de políticas públicas. Essa abordagem metodológica é especialmente relevante para este trabalho, pois permite uma análise detalhada das práticas e desafios enfrentados pelos conselhos municipais de saúde, oferecendo contribuições valiosas para o aprimoramento das políticas públicas e do controle social na região.

Conforme Teófilo e Martins (2007), a pesquisa qualitativa privilegia dados descritivos e um foco no processo em detrimento apenas dos resultados. Esse método envolve uma análise indutiva, na qual os dados são coletados, organizados e analisados à medida que emergem, permitindo que padrões e tendências sejam identificados. Essa abordagem é particularmente adequada para capturar o significado das ações sociais e entender a perspectiva dos envolvidos.

8.1 PESQUISA DOCUMENTAL

A pesquisa documental utilizada neste trabalho considera documentos primários, como atas de reuniões, pareceres e atos administrativos dos conselhos de saúde dos quatro municípios escolhidos. A análise desses materiais segue os princípios estabelecidos por GUBA E LINCOLN (1981), que destacam a importância da reinterpretação de fontes documentais para descobrir novos ângulos e aprofundar a compreensão de fenômenos sociais. Essa abordagem será complementada pela categorização dos dados, conforme descrito por BOGDAN E BIKLEN (1994), em que tópicos recorrentes e padrões são organizados em categorias representativas para uma análise sistemática.

8.2 ENTREVISTAS SEMI ESTRUTURADAS

Além da pesquisa documental, serão realizadas entrevistas semiestruturadas com os membros dos respectivos Conselhos Municipais de Saúde e com autoridades públicas locais. Esse tipo de

permite ao pesquisador seguir um roteiro previamente elaborado, mas com flexibilidade para explorar novas questões que emergem no decorrer da conversa. De acordo com Triviños (1987), a entrevista semiestruturada combina perguntas básicas definidas a partir dos objetivos da pesquisa com a liberdade de aprofundar determinados temas conforme a interação com o entrevistado. Essa técnica possibilita captar percepções, significados e experiências que dificilmente emergiriam em instrumentos mais rígidos. Na área da saúde, Minayo (2017) destaca que a entrevista semiestruturada é fundamental para compreender as práticas sociais e institucionais dos sujeitos, permitindo que expressem suas visões de mundo e suas interpretações sobre o funcionamento das políticas públicas. Assim, a adoção desse procedimento metodológico se justifica pela necessidade de compreender de forma aprofundada as percepções dos conselheiros e gestores sobre a efetividade do controle social, suas dificuldades cotidianas e os fatores que condicionam o funcionamento dos conselhos no contexto do Norte de Minas Gerais.

8.3 MODELO QUADRIPOlar DE PESQUISA

A metodologia deste estudo também se alinha ao modelo quadripolar descrito por TEÓFILO E MARTINS (2007), que integra os pólos epistemológico, teórico, metodológico e técnico.

Polo epistemológico: reflete a produção e validação do conhecimento, garantindo a confiabilidade e a validade dos dados coletados. Isso inclui o uso de fontes oficiais, como documentos dos conselhos, e a aplicação de técnicas rigorosas de categorização.

Polo teórico: baseia-se no conceito de controle social e participação popular, considerando a necessidade de um olhar crítico sobre as práticas dos conselhos de políticas públicas e sua integração com a administração pública.

Polo metodológico: envolve a aplicação de análise de conteúdo, categorização de dados e entrevistas para aprofundar a compreensão sobre o funcionamento dos conselhos de saúde.

Polo técnico: diz respeito à escolha e aplicação das técnicas de coleta e análise de dados, como a organização dos documentos e a condução das entrevistas.

8.4 ANÁLISE DE CONTEÚDO

A técnica de análise de conteúdo será utilizada para organizar e interpretar as informações coletadas. Segundo ALMEIDA E GUINDANI (2009), essa técnica permite uma análise objetiva e sistemática da comunicação, facilitando a identificação de padrões e tendências nos dados. A categorização envolverá a criação de blocos temáticos que representarão as principais questões identificadas nas atas e nos relatos dos entrevistados.

8.5 VALIDAÇÃO E GENERALIZAÇÃO

Conforme apontado por TEÓFILO E MARTINS (2007), a validade do estudo será assegurada por meio da triangulação de métodos (documentos e entrevistas) e pelo cruzamento de informações obtidas em diferentes fontes. Essa estratégia aumenta a confiabilidade dos achados e amplia as possibilidades de generalização, embora seja necessário reconhecer as limitações contextuais do estudo, principalmente em relação às especificidades da Região Norte de Minas Gerais.

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARISTÓTELES. Política. Tradução de Mário da Gama Kury. Brasília: Editora da UnB, 1991.
- BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Paz e Terra, 1986.
- BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
- BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011.
- BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
- BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
- BRAVO, Maria Inês Souza; CORREIA, Maria Valéria Costa. Desafios do controle social na atualidade. São Paulo: Cortez, 2012.
- BREILH, Jaime. Epidemiologia crítica: ciência emancipadora e interculturalidade. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006.
- BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Em busca do desenvolvimento perdido: um projeto novo-desenvolvimentista para o Brasil. São Paulo: FGV Editora, 2018.
- BUSS, Paulo Marchiori; PELLEGRINI FILHO, Alberto. A saúde e seus determinantes sociais. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 77-93, 2007.
- CIRINO, Jader Fernandes; GONZÁLEZ, Alba Maria Guadalupe Orellana. A heterogeneidade do desenvolvimento econômico do estado de Minas Gerais. *Revista de Ciências Humanas*, Viçosa, MG, v. 21, n. 2, p. 129-146, jul./dez. 2021. DOI: 10.5902/2238212623476. Disponível em: <https://periodicos.ufv.br/RCH/article/view/3476>. Acesso em: 9 nov. 2025.
- CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado: pesquisas de antropologia política. Tradução de Theo Santiago. São Paulo: Brasiliense, 1978.
- CONASEMS. Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Manual dos Conselhos de Saúde. Brasília: Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, 1995.
- DAGNINO, Evelina. Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2004.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
- DURKHEIM, Émile. A divisão do trabalho social. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2005.
- FAGNANI, Eduardo. Política social no Brasil (1964-2002): entre a cidadania e a caridade. 2005. Tese (Doutorado em Ciências Econômicas) – Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005.
- FARIAS FILHO, Milton Cordeiro; SILVA, Andréia Neves da; MATHIS, Armin. Os limites da ação coletiva nos Conselhos Municipais de Saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 19, n. 6, p. 1911-1919, 2014.
- FERREIRA, L. T.; COSTA, M. L. Desigualdade e governança no Norte de Minas Gerais: o impacto da infraestrutura deficiente na gestão pública. *Revista de Desenvolvimento Regional*, v. 18, n. 1, p. 99-114, 2022.

FERREIRA, M. D.; OLIVEIRA, T. S. A participação social no Brasil: o caso dos conselhos de políticas públicas e sua efetividade na gestão pública. Cadernos de Administração Pública, 2021.

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 34. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

GERSCHMAN, S. Descentralização e equidade no SUS: dilemas e desafios. Ciência & Saúde Coletiva, v. 9, n. 2, p. 339-350, 2004.

GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GIOVANELLA, L. et al. Atenção primária à saúde: seletiva ou integral? Cadernos de Saúde Pública, v. 25, n. 3, p. 409-420, 2009.

GUBA, Egon; LINCOLN, Yvonna. Effective evaluation: improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approaches. San Francisco: Jossey-Bass, 1981.

HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. Tradução de Lúcia Brito. São Paulo: L&PM, 2015.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Técnicas de pesquisas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

LANDERDHAL, Maria Celeste et al. Resoluções do Conselho de Saúde: instrumento de controle social ou documento burocrático? Ciência & Saúde Coletiva, v. 15, n. 5, p. 2431-2436, 2010.

LEFEBVRE, Georges. A Revolução Francesa. Tradução de Magda Lopes. São Paulo: Ática, 2001.

LIMA, L. D. et al. Descentralização, regionalização e instâncias intergovernamentais do SUS. Ciência & Saúde Coletiva, v. 11, n. 5, p. 1211-1222, 2006.

LIMA, Nísia Trindade. Saúde e democracia: história e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2019.

MARTINS, Gilberto de Andrade; THEÓPHILO, Carlos Renato. Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas. São Paulo: Atlas, 2007.

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. 10. ed. São Paulo: Abril, 1975.

MBITI, John S. African religions and philosophy. 2. ed. Oxford: Heinemann, 1990.

MELO, Sandro César de; SANTOS, Silvane Aparecida dos; SANTOS, Vinícius José dos. Índice Social e de Saúde (ISS) para os municípios do Norte de Minas Gerais. *Revista Desenvolvimento Social*, Montes Claros, v. 27, n. 1, p. 203-222, jan./jun. 2021. Disponível em: <https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/rds/article/view/4658>. Acesso em: 9 nov. 2025.

MINAS GERAIS. Tribunal de Contas. Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo. Manual de elaboração de trabalhos acadêmicos. Belo Horizonte, 2017.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. 15. ed. São Paulo: Hucitec, 2017.

OLIVEIRA, R. S.; SILVA, A. M. A participação popular no Brasil: limites e avanços no controle social das políticas públicas. Cadernos de Administração Pública, v. 24, n. 2, p. 45-58, 2020.

PAIM, Jairnilson Silva. O que é o SUS. São Paulo: Editora Fiocruz, 2008.

PALHARES, Ricardo Henrique; HERMANO, Vivian Mendes; SILVA, Jefferson Gonçalves da. Movimento pendular e a busca por serviços de saúde em Montes Claros – MG. *Revista Eletrônica da Associação dos*

Geógrafos Brasileiros, Seção Três Lagoas, v. 1, n. 37, p. 113-135, 12 jul. 2023. DOI: 10.55028/agb-tl.v1i37.17774.

RICARDO, David. *Princípios de economia política e tributação*. 3. ed. São Paulo: Pioneira, 2000.

ROCHA, A. F.; LIMA, F. P. Desafios para a implementação de políticas públicas no Norte de Minas Gerais: uma análise das limitações no acesso aos direitos fundamentais. *Revista de Políticas Públicas Regionais*, 2019.

ROSANVALLON, Pierre. *A contrademocracia: a política na era da desconfiança*. Tradução de André Telles. São Paulo: Cambridge University Press, 2006.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Políticas públicas e controle social: desafios e possibilidades na periferia urbana. *Revista Brasileira de Sociologia*, v. 63, n. 3, p. 145-162, 2021.

SEN, Amartya. *Desenvolvimento como liberdade*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

SILVA, M. R.; PEREIRA, M. F. *Gestão e organização do SUS*. São Paulo: Hucitec, 2016.

SIMONSEN, Roberto. Controle social, institucionalismo e planejamento. *Revista Estudos Econômicos*, 2016

SMITH, Adam. *A riqueza das nações*. 7. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1992.

STIGLITZ, Joseph E. *O preço da desigualdade: o que a sociedade dividida de hoje significa para o nosso futuro*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

STRALEN, Cornelis Johannes van et al. Conselhos de saúde: efetividade do controle social em municípios de Goiás e Mato Grosso do Sul. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 11, n. 3, p. 621-632, 2006.

TATAGIBA, Luciana. Conselhos gestores e a democratização das políticas públicas no Brasil. In: DAGNINO, Evelina. *Sociedade civil e espaços públicos no Brasil*. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

TODOROV, Tzvetan. *A conquista da América: a questão do outro*. Tradução de Beatriz Sidou. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. *Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação*. São Paulo: Atlas, 1987.

TUTU, Desmond. *No future without forgiveness*. New York: Image, 1999.

VIEIRA, F. S.; SANTOS, I. S. Federalismo fiscal e financiamento da saúde. *Saúde em Debate*, v. 35, n. 90, p. 25-37, 2011.

WEBER, Max. *A ética protestante e o espírito do capitalismo*. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

ZAMBON, Vera Dib; OGATA, Márcia Niituma. Controle social do Sistema Único de Saúde: o que pensam os conselheiros municipais de saúde. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 66, n. 6, p. 921-927, 2013.

.

